

Radiologie in München Harlaching- Grünwalder Str. 72 – 81547 München

Herrn Chefarzt
Prof. Dr.med. Markus Walther
Ärztlicher Direktor
Zentrum für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie
Schön Klinik Harlaching
Harlacherstr. 51
81547 München

München 12.01.2022

Betr.: DENIFFEL Thomas, geb. am 06.04.1994

Sehr geehrter Herr Kollege Walther,
vielen Dank für die freundliche Überweisung Ihres o. g. Patienten.

Klinische Angaben: Persistierender Reizzustand 2. Grundgelenk linker Vorfuß mit Knochenödem MT-Kopf II. Anamnestisch persistierende Schmerzen MTP-Gelenk II links, kein akutes Trauma, Z.n. OP am 16.2.2021: Synovektomie und PE Entnahme MTP-Gelenk II linker Vorfuß, Verkürzungsosteotomie MT-Kopf II, Naht plantare Platte von plantar MTP II. Zum Vergleich liegen mehrere VA vor, zuletzt eine MRT vom 8.12.2021.

3T- MRT des linken Vorfußes (hochauflösende 18-Kanalspule) vom 12.01.2022:

Durchgeführt wurden folgende Sequenzen: T1w und PDw fatsat schräg coronar, T1w axial und PDw fatsat sagittal, nach i.v. KM-Gabe axiale und coronare T1w fatsat.

Leichte Metallartefakte bei Zustand nach Verkürzungsosteotomie MT-Köpfchen II.
Im Vergleich zur VU zunehmendes Knochenödem distale Diaphyse bis Köpfchen MT II mit leichter Knochenmarksignalabsenkung in T1w. Eine etwas prominente knöcherne plantarseitige Ausbuchtung am MT-Köpfchen II lateral reicht relativ weit nach plantar mit Knochenödem (Serie 7/Bild 27). Im Vergleich zur VU soweit im Liegen beurteilbar, V.a. leichte Subluxation im MTP-Gelenk II bei keilförmiger Gelenkspalterweiterung dorsal und initialem Knochenkontakt zwischen zentralem MT-Köpfchen II und plantarseitiger Basis der Grundphalanx II (Serie 6/Bild 20). Bei Z.n. Naht der plantaren Platte II weitgehend unveränderte, lateral betonte mukoider Auftreibung, Auffaserung, Unregelmäßigkeiten und fibrovaskuläre Aktivierung der plantaren Platte II mit eröffnetem fibrösem Tunnel der Beugeschnen II.
Regelrechtes Knochenmarksignal der übrigen Metatarsalia. Im GZGG Knorpel und Kapselbandapparat intakt, kein Erguss oder Synovialitis. Mediales und laterales Sesambein unauffällig. Sesambeingleitlager regelrecht. Unauffällige Darstellung der MTP-Gelenke III-V mit regelrechter Darstellung der plantaren Platten III/V. Durchgängige Flexorensehnen und Extensorensehnen. Regelrechte Darstellung der kleinen Fußmuskulatur.

Beurteilung: Im Vgl. zur VU (12/2021) zunehmendes Knochenödem distale MT-Diaphyse bis Köpfchen II links, ohne Zeichen einer Osteonekrose. Bei Z.n. Naht der plantaren Platte II weitgehend unveränderte, lateral betonte mukoider Auftreibung, Auffaserung, Unregelmäßigkeiten und fibrovaskuläre Aktivierung der plantaren Platte II mit eröffnetem fibrösem Tunnel der Beugeschnen II. Soweit im Liegen beurteilbar, V.a. leichte Subluxation im MTP-Gelenk II, als Hinweis auf mögliche Insuffizienz der plantaren Platte II.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen


Prof. Dr. med. A. Stäbler (vidit)
Facharzt für Radiologie


Dr. med. H. Schenk
Fachärztin für Radiologie



Radiologische Praxis München Großhadern – Sauerbruchstr. 10 - 81377 München

Herrn
Prof. Dr.med. Markus Walther
Ärztlicher Direktor
CA des Zentrum für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie
Schön Klinik
Harlachingerstr. 51
81547 München

München, den 30.11.2022

Betr.: DENIFFEL, Thomas, geb. 06.04.1994

Sehr geehrter Herr Kollege Walther,
vielen Dank für die freundliche Überweisung Ihres o. g. Patienten.

Klinische Angaben: MRT des linken Vorfußes als Verlaufskontrolle bei Zustand nach Verkürzungsosteotomie Metatarsaleköpfchen II, Zustand nach OP plantare Platte 02/21. Voruntersuchung vom 12.1.2022.

3T-MRT linker Vorfuß (hochauflösende Mehrkanalspule) vom 30.11.2022:

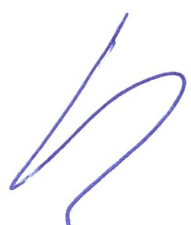
Durchgeführt wurden folgende Sequenzen: T1w und PDw fatsat schräg coronar, T1w axial, PDw fatsat sagittal; T1w fs coronar und axial nach KM-Gabe(17ml GD-Dota).

Im Vergleich zur Voruntersuchung hat sich das Knochenmarködem im Köpfchen Os metatarsale II vollständig zurückgebildet, bekanntes verbliebenes zentrales postoperatives Metallartefakt. Die angrenzenden Gelenkpartner sind unauffällig, keine subchondrale Aktivierung, kein Knorpelschaden, keine eindeutige Fehlstellung, allenfalls minimale Dezentrierung nach streckseitig. Keine knöcherne Entrundung. Übrige abgebildete Gelenkverbindungen ebenfalls unauffällig. Bekannt narbig veränderte plantare Platte fibulaseitig mit geringer mukoider Auftreibung. Der fibröse Tunnel nicht mehr eindeutig eröffnet. Nach Kontrastmittelgabe zeigt keine pathologische Kontrastmittelaufnahme in diesem Bereich. Kein Mortonneurom. Unauffällig kleine Fußmuskulatur. Deutliches plantares Überlastungsgebe in Höhe des Metatarsophalangealgelenkes V.

Beurteilung: Im Vgl. zur VU 01/22 hat sich das Knochenmarködem im Köpfchen Os metatarsale I bei Zustand nach Verkürzungsosteotomie vollständig zurückgebildet. Keine fibrovaskuläre Reizung im Bereich der narbig postoperativ veränderten plantaren Platte an dem II fibulaseitig bei bekannter mukoider Veränderung, die plantare Platte ist nun durchgängig. Weiterhin angedeutete Subluxationsstellung im MTP II Gelenk.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med. A. Stäbler(vidit)
Facharzt für Radiologie


Dr. med. M. Kaemmerer
Facharzt für Radiologie